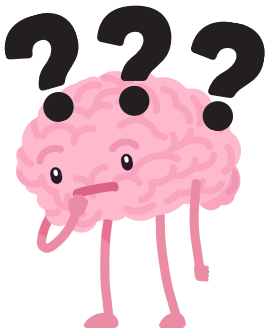


OBJECTIF CERTIF



Mai 2026

Certification des établissements de santé : êtes vous prêts ?



C'est quoi ?

La certification des établissements de santé est un levier essentiel pour garantir la qualité et la sécurité des soins.



Qui ?

Tous les établissements de santé, publics et privés.

Par qui ?

Par des experts-visiteurs, qui sont des professionnels en exercice en établissement de santé, mandatés par la HAS.

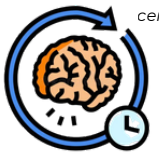
Comment ?

Lors d'une visite de l'établissement, les experts-visiteurs évaluent le niveau de la qualité des soins. Ils s'appuient sur un référentiel qui établit 15 objectifs déclinés en critères appréciés au moyen de méthodes proches du terrain.



Quel résultat ?

Les résultats obtenus pour chaque critère permettent de calculer un score global qui exprime le niveau de la qualité des soins de l'établissement.



Les résultats de la dernière certification en date de mai 2022

Quelques chiffres clés

157
Critères au total

21
Critères impératifs



seulement **15** *aux urgences*

Critères → Exigence évaluée

Critère impératif → Exigence non négociable

3
Chapitres



Chapitre 1
Le patient



Chapitre 2
Les équipes de soins



Chapitre 3
L'établissement

5
Méthodes d'évaluation



- Patient traceur
- Parcours traceur
- Traceur ciblé
- Audit système
- Observations

Pour aller plus loin

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

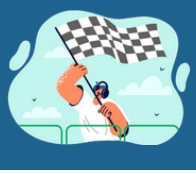
Newsletter n°1 - Certification des établissements de santé : êtes vous prêts ?

Diffusion en interne

Service des urgences

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Création G. SILVETTI



OBJECTIF CERTIF



Mai 2026

Certification : Tout un programme



Octobre 2026

3 à 8 jours

2 à 8 experts-visiteurs et 1 coordonnateur

Le calendrier précis sera connu en septembre 2026

Des critères spécifiques aux urgences

2.3-03 : Compléter l'échelle de tri aux urgences avec les références société savante.

2.3-03 : Améliorer la communication des délais d'attente en temps réel aux patients.

2.3-03 : Améliorer la traçabilité des avis spécialisés dans le dossier.

2.3-03 : Mettre en place l'accès au dossier médical partagé de Mon espace santé pour les urgentistes.

3.3-05 : Définir un programme d'amélioration à partir des résultats d'indicateurs de prise en charge non programmés des patients âgés (nbre total, de passage aux urgences des patients âgés de 75 ans et plus suivis d'une hospitalisation,...).

Des critères spécifiques à l'hygiène hospitalière

2.2-08 : respecter les prérequis à l'hygiène des mains : 0 bijoux aux mains et aux poignets, manches courtes, absence de vernis, ongles courts.

2.2-08 : Harmoniser la conduite à tenir en cas d'AES.

2.2-08 : Rappeler les bonnes pratiques de gestion des excreta et vérifier la présence de gants et de SHA dans les locaux des laves bassins.

2.2-09 : Appliquer les bonnes pratiques du port de masque (pas de masque en collier).



12 GRANDS Thèmes

Urgences vitales
Circuit du médicament & pharmacovigilance
Identification, identitovigilance et dossier de soins
Bientraitance, dignité, information et confidentialité
Droits des patients
Hygiène - Prévention du risques infectieux
Prise en charge de la douleur
Gestion de crise et procédures dégradées
Prévention du risque numérique
Sécurité transfusionnelle
Gestion des risques et démarche qualité
Les 5 méthodes d'évaluation de la certification

Ma semaine en mode certif



Lundi	Mardi	Mercredi
Newsletter	Point staff 14h30	Challenge

Jeudi	Vendredi
Point staff 14h30	À garder en mémoire

Pour aller plus loin

HAS Haute Autorité de Santé

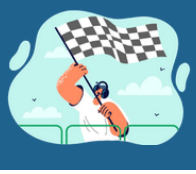
Newsletter n°1 - Certification des établissements de santé : êtes vous prêts ?

Diffusion en interne

Service des urgences

Hôpitaux Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Création G. SILVETTI



OBJECTIF CERTIF



Mai 2026

Identification et identitovigilance

Les critères impératifs :

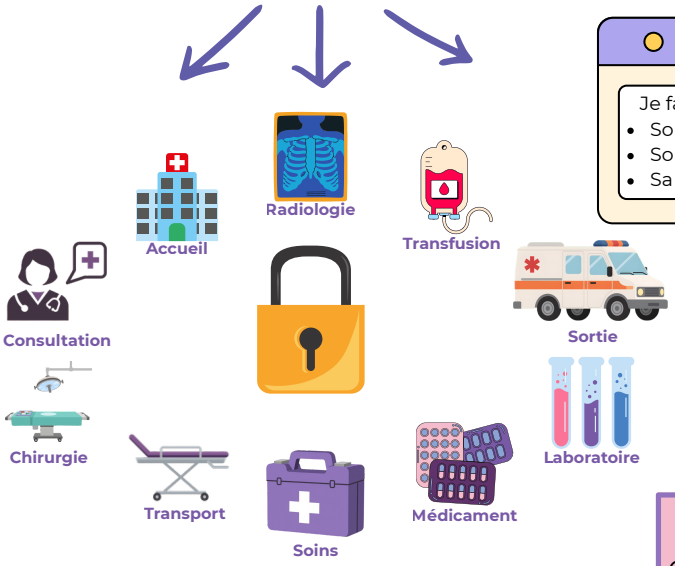
Chapitre 2 - Les équipes de soins

2.2-01 : Les équipes **respectent** les **bonnes pratiques d'identification** du patient à toutes les étapes de sa prise en charge.

L'identitovigilance permet de limiter le risque d'erreurs potentiellement graves liées à une mauvaise identification (erreur de site opératoire, erreur de traitement, erreurs de résultats de laboratoire…).

L'identification fiable et unique du patient à chaque venue et à toutes les étapes de sa prise en charge permet de relier l'identité d'une personne à un acte.

L'identité doit être vérifié à chaque étape de la prise en charge du patient (examen, transfert, …).



Je fais **décliner** au patient :
- Son nom
- Son prénom
- Sa date de naissance

2021

Identité nationale de santé (I.N.S)

L'INS est un identifiant national unique et permanent pour chaque usager du système de santé. Il est constitué du **numéro d'identification de l'individu au répertoire des personnes physiques** (NIR ou NIA) et des **traits d'identité de référence** provenant de la base nationale d'état civil (nom de naissance, prénom(s), sexe, date de naissance, lieu de naissance).

À l'admission, l'INS doit être qualifiée.

BRACELET D'IDENTIFICATION

Si le patient n'a pas la capacité de décliner son identité, l'identification secondaire du patient est assurée par un dispositif d'identification adapté



Dispositif physique d'identification proposé systématiquement à tous les patients et OBLIGATOIRE

Identification des documents

Chaque document papier du dossier patient est identifié

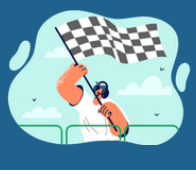
Les documents contenant des données de santé doivent comporter a minima sur la première page :

- *nom de naissance,*
- *premier prénom de naissance,*
- *liste des prénoms,*
- *date de naissance,*
- *sexe,*
- *Numéro d'identification institutionnel (IPP)*





Toute erreur d'identité doit être signalé et corrigé !
En cas de doublon, prévenir la cellule d'identitovigilance
Envoyé un mail à : identito-vigilance@ghpsj.fr



OBJECTIF CERTIF



Dossier de soins

Mai 2026

Les critères standards :

Chapitre 1 & 2- Le patient & les équipes de soins

1.1-08 : Le patient **accède** à son dossier de soins dans les **délais légaux**.

2.1-02 : Les équipes de soins ont **accès aux informations** du patient avec un **système d'information adapté**

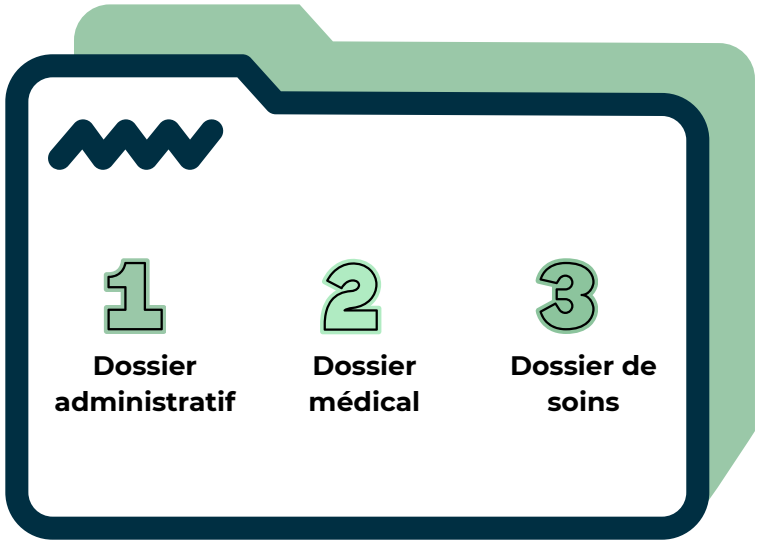
Le dossier du patient est le lieu de recueil et de conservation des informations administratives, médicales et paramédicales, formalisées et actualisées, enregistrées pour tout patient accueilli, à quelque titre que ce soit, dans un établissement de santé.



Le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 confirme dans son article 9 l'obligation de constituer un dossier pour tout patient hospitalisé ou consultant dans un établissement de santé public ou privé. Le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 reprend cette obligation dans son article R. 1112-2.

La bonne tenue du dossier contribue à la continuité, la sécurité et l'efficacité des soins.

Elle est le reflet de la pratique professionnelle et de sa qualité. Le dossier permet des actions d'évaluation et d'amélioration de la qualité des soins.



Selon le CSP, toute personne le droit d'accéder aux informations relatives à sa santé détenues par un professionnel ou un établissement de santé public ou privé (article L. 1111-7 issu de la loi du 4 mars 2002) et les professionnels de santé ont une obligation d'information.

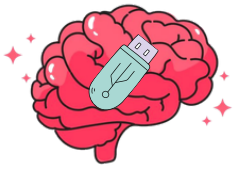
Demande d'accès au dossier médical

Demande en ligne

Service des relations patients

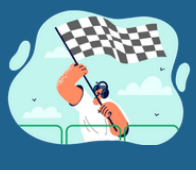
relationspatients@ghpsj.fr

01 44 12 35 85



Le dossier du patient a un rôle de mémoire du patient et des professionnels, de communication et de coordination ; ses fonctions sont multiples :

- mise à disposition d'informations nécessaires et utiles à la prise en charge et au suivi ;
- traçabilité des soins et des actions entreprises vis-à-vis du patient ;
- continuité des soins ;
- aide à la décision thérapeutique par son contenu ;
- lieu de recueil du consentement éclairé du patient, de l'analyse bénéfices-risques et de la traçabilité de la décision ;
- évaluation de la qualité des soins et de la tenue du dossier ;
- enseignement et recherche ;
- extraction des informations nécessaires à l'analyse médico-économique de
- l'activité, notamment à la médicalisation du système d'information (PMSI) et à
- ses contrôles de qualité ;
- rôle juridique important dans le cas d'une recherche de responsabilité.



OBJECTIF CERTIF

Mai 2026

Droits des patients et prise en charge particulière

Les critères impératifs :

Chapitre 1, 2 et 3 - Le patient, les équipes de soins et l'établissement

1.3-01 : Le patient **exprime** son **consentement libre** et **éclairé** sur son projet de soins et ses modalités.

1.4-02 : La **satisfaction** et l'**expérience** du patient sont **prises en compte**.

Mineurs :

1.1-02 : Le patient **mineur** bénéficie d'un **environnement adapté**.

Psychiatrie :

2.1-12 : Les équipes **réalisent** un **examen somatique** pour tout patient **hospitalisé en psychiatrie**.

2.3-14 : Les équipes **respectent** les bonnes pratiques **d'isolement**, qu'il soit assorti ou non de **contentions**, des **patients** hospitalisés **sans consentement**.

Personne âgée :

3.3-05 : L'établissement **prévient** les **transferts évitables** des **personnes âgées**.

Dans le cadre de la prise en charge des patients, le respect de leurs droits constitue un élément fondamental de la qualité et de la sécurité des soins. Certaines situations nécessitent également une attention particulière et une adaptation des pratiques professionnelles.



Les lois



Les droits des patients s'appuient sur plusieurs lois fondamentales qui encadrent la pratique des professionnels de santé en France :

- **La loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner)**
  - Relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : elle pose les bases du droit à l'information, du consentement libre et éclairé, de l'accès au dossier médical, et introduit la notion de personne de confiance.
- **La loi du 22 avril 2005 (loi Leonetti)**
  - Relative aux droits des malades et à la fin de vie : elle encadre la limitation ou l'arrêt des traitements et renforce la lutte contre l'obstination déraisonnable.
- **La loi du 2 février 2016 (loi Claeys-Leonetti)**
  - Elle complète la précédente en rendant les directives anticipées contraignantes et en instaurant le droit à une sédation profonde et continue dans certaines situations de fin de vie.
- **Le Code de la santé publique**
  - Il regroupe l'ensemble des dispositions légales relatives aux droits des patients (information, consentement, secret médical, etc.).

Les chartes

En complément des lois, plusieurs chartes encadrent et rappellent les droits des patients dans les établissements de santé.



- **La Charte de la personne hospitalisée (2006)**
  - Elle précise les droits essentiels du patient hospitalisé, notamment le respect de la dignité, de la vie privée, l'accès à l'information, le consentement aux soins et la possibilité de désigner une personne de confiance.
- **La Charte de la personne âgée ... (2007)**
  - Elle vise à garantir le respect, la dignité, l'autonomie et la qualité de vie des personnes âgées en situation de dépendance.
- **La Charte du parcours de santé**
  - Elle met l'accent sur une prise en charge coordonnée, continue et centrée sur le patient, en favorisant la coopération entre les professionnels et l'implication du patient dans son parcours de soins.
- **La Charte de la laïcité dans les services publics**
  - Elle garantit la neutralité et le respect des croyances de chacun dans le cadre des soins.

E-Satis



E-Satis est l'enquête de satisfaction nationale. Elle est envoyée par mail au patient après son hospitalisation de plus de 48h ou en chirurgie ambulatoire. L'enquête comporte une 60aine de questions.

Les résultats sont publics et publiés sur le site "scope santé".

Pour chaque service, les commentaires des patients sont envoyés à l'encadrement par les secrétaires de coordination.

Exemple d'axes d'améliorations :

- L'accueil.
- Le repas.
- L'organisation de la sortie.

La satisfaction des patients compte depuis 2019 comme un indicateur participant au financement à la qualité des établissement de santé.

Important

- **Recueil des mails des patients à l'entrée.**
- **Information du patient sur le fait qu'il va recevoir une enquête de satisfaction par mail après sa sortie.**

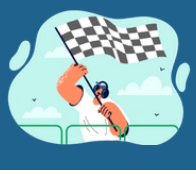
Les relations des usagers



En France, la notion de représentation des usagers a pris de l'ampleur à partir des années 1990.

La loi Kouchner, du 4 mars 2002, a renforcé la participation des usagers dans le système de santé français.

Le représentant des usagers est une personne bénévole, désignée ou élue pour représenter les intérêts et les droits des usagers dans le système de santé. Son rôle est de défendre les droits des usagers, de faire entendre leur voix et de contribuer à l'amélioration de la qualité des services de santé.
Il peut également participer à l'élaboration des politiques et des décisions concernant les enjeux de santé.



OBJECTIF CERTIF

Mai 2026

Droits des patients et prise en charge particulière

Les critères impératifs :

Chapitre 1, 2 et 3 - Le patient, les équipes de soins et l'établissement

1.3-01 : Le patient **exprime** son **consentement libre** et **éclairé** sur son projet de soins et ses modalités.

1.4-02 : La **satisfaction** et l'**expérience** du patient sont **prises en compte**.

Mineurs :

1.1-02 : Le patient **mineur** bénéficie d'un **environnement adapté**.

Psychiatrie :

2.1-12 : Les équipes **réalisent** un **examen somatique** pour tout patient **hospitalisé en psychiatrie**.

2.3-14 : Les équipes **respectent** les bonnes pratiques **d'isolement**, qu'il soit assorti ou non de **contentions**, des **patients** hospitalisés **sans consentement**.

Personne âgée :

3.3-05 : L'établissement **prévient** les **transferts évitables** des **personnes âgées**.

La CDU

Une **Commission des usagers (CDU)** est installée dans chaque établissement de santé public et privé pour veiller au respect des droits des usagers, faciliter leurs démarches et contribuer par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches.

La composition de la **CDU** varie, mais elle inclut à minima le représentant de l'établissement de santé, des représentants des usagers, un médiateur médecin et son suppléant, un médiateur non-médecin et son suppléant.

Les représentants des usagers sont désignés par la Directrice générale de l'Agence régionale de santé sur proposition de leur association de rattachement.

L'objectif est d'assurer une collaboration constructive entre les différents acteurs pour améliorer la qualité des soins et garantir le respect des droits des usagers.

Directives anticipées

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des **directives anticipées (DA)** pour le cas où, en cas de lésions irréversibles ou de maladie grave, elle serait hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces **DA** indiquent ses souhaits de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou des actes médicaux.



Rédiger ses **DA** est un droit que tout citoyen doit connaître et peut exercer.

Elles peuvent être rédigées sur un papier libre ou sur un formulaire.

Il n'est pas nécessaire d'être malade ou âgé. La rédaction peut être faite par avance.

Consentement

Le consentement doit être "libre et éclairé".

Cela signifie qu'il ne doit pas être obtenu sous la contrainte.

Le patient doit donner son consentement après avoir reçu préalablement du médecin une information claire, complète, compréhensible et appropriée à sa situation.



Le consentement du patient doit être exprès.

Il doit donc être donné de façon manifeste et claire, par oral.

Il n'y a pas de formalisme en matière de recueil du consentement : l'expression du consentement du patient n'est pas subordonnée à l'établissement d'un écrit.

Les personnes

Ces deux notions sont souvent assimilées, mais elles ont des rôles bien distincts. Il est donc essentiel de bien les différencier afin de respecter les droits du patient et d'assurer une prise en charge adaptée.

Personne à prévenir

La personne à prévenir en cas d'urgence est la première personne contactée par l'équipe soignante en cas d'hospitalisation ou d'aggravation de votre état de santé.



Personne de confiance

La personne de confiance a comme rôle de vous accompagner dans vos démarches liées à votre santé et d'exprimer votre volonté si vous êtes, un jour en incapacité de le faire.

À retenir : ne pas confondre la personne de confiance et la personne à prévenir.

Mineur

Sauf urgences vitales, il faut obtenir une autorisation d'hospitalisation, de soins, et d'acte interventionnel auprès des personnes ayant l'autorité parentale ou le représentant légal.



- **Chambre seule ou non partagée avec un adulte, prés du poste de soins.**
- **Accompagnement d'un parent favorisé au maximum (nuit, transport, examen).**
- **Un mineur ne doit jamais être seul avec une personne.**

Psychiatrie



Tout patient doit bénéficier d'un examen somatique complet, afin d'éliminer toute cause organique, sauf dans le cadre d'une consultation exclusivement psychiatrique.

La contention est strictement encadrée et associée à :

- **une contention physique (3 ou 5 points selon la situation),**
- **une contention chimique (traitements adaptés).**
- **Surveillance rigoureuse et tracée dans le dossier de soins, afin de garantir la sécurité et le respect des droits du patient.**



Pour monter un brancard à contention

Pour aller plus loin

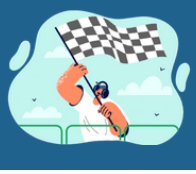
HAS HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Diffusion en interne

Service des urgences

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Création G. SILVETTI



OBJECTIF CERTIF



Prise en charge de la douleur

Mai 2026

Les critères impératifs :

Chapitre 1 - Le patient

1.1-05 : Le patient **bénéficie** de **soins** visant à **anticiper** ou à **soulager** sa douleur



L'évaluation et la prise en charge de la douleur constituent une priorité de santé publique et un révélateur de la qualité de la pratique clinique. **La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002** reconnaît le soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne.

En 2016, la loi de modernisation du système de santé intègre la prévention de la douleur dans les priorités de la politique nationale de santé ; elle inscrit la prise en charge de la douleur dans le parcours de soins, y compris le recours aux structures spécialisées et reconnait l'importance du caractère pluriprofessionnel de l'équipe de soins.

Définition :

« Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle »

Conseil de l'IASP (International Association for the Study of Pain)

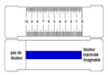
Différentes échelles :



Echelle d'auto-évaluation

Echelle Visuelle Analogique (EVA)

Echelle unidimensionnelle (intensité) sous forme de réglette graduée de 0 à 10 sur une face (face soignant) avec un curseur que l'adulte peut déplacer sur l'autre face.



Echelle Numérique (EN)

Le soignant demande au patient d'évaluer l'intensité de la douleur au moment présents



Echelle Visuelle Simple (EVS)

Le soignant demande au patient d'évaluer l'intensité de la douleur au moment présent selon les consignes ci-dessous.

Absence de douleur	0
Douleur faible	1
Douleur modérée	2
Douleur intense	3
Douleur extrêmement intense	4

Echelle d'hétéro-évaluation

Doloplus

Echelle comportant dix items cotés chacun de 0 à 3 (quatre niveaux), ce qui amène à un score global compris entre 0 et 30

Algoplus

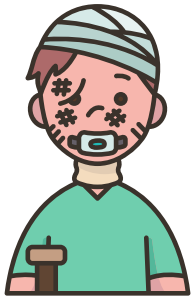
Echelle d'évaluation comportementale de la douleur aiguë chez la personne âgée présentant des troubles de la communication verbale score de 0 à 5

Echelle douleur neuropathique

DN4

4 questions réparties en 10 items. Le diagnostic de la douleur neuropathique est porté si le score du patient est supérieur ou égal à 4/10.

Les différents types de douleurs :



- Douleur aigüe
- Douleur chronique
- Douleur rebelle
- Douleur liée aux soins
- Douleur par mécanisme psychogène

OBJECTIF CERTIF

Prise en charge de la douleur

Mai 2026

Les critères impératifs :

Chapitre 1 - Le patient

1.1-05 : Le patient **bénéficie** de **soins** visant à **anticiper** ou à **soulager** sa douleur

Point clés de l'évaluation

La prise en charge de la douleur suppose un dialogue régulier avec le patient. En effet, le plus souvent, lui seul est capable d'indiquer aux soignants ce qu'il ressent.

Son engagement est donc requis lorsque cela est possible. Ainsi, vous vous assurerez que le patient est encouragé à exprimer sa douleur et est entendu des équipes, jusqu'au soulagement de celle-ci.

La HAS, selon son référentiel mentionne que les équipes doivent :



- Écouter les plaintes des patients et observer les éventuelles attitudes ou signes algiques du patient ;
- Évaluer l'intensité de la douleur, dès l'arrivée du patient, à l'aide d'une échelle validée, adaptée à l'âge et à l'état cognitif du patient (échelle verbale simple, échelle visuelle analogique, échelle Algoplus, échelle de visage, questionnaire DN4 ...) ;
- Évaluer également la fréquence et la chronicité de cette douleur ;
- Rechercher la cause de la douleur (douleur d'origine lésionnelle, douleur d'origine psychogène...) ;
- Informer et rassurer le patient sur la douleur ressentie et la prise en charge qui va lui être apportée ;
- Tracer l'évaluation initiale dans le dossier du patient ;
- Anticiper les acte et soins douloureux : prise d'antalgique par anticipation, remise de l'ordonnance d'antalgique.

Le MEOPA

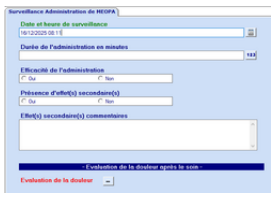


Le Méopa, pour mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote, est comme son nom l'indique, un mélange à parts égales d'oxygène et de protoxyde d'azote.

Il est prescrit pour soulager la douleur ou aider les patients à gérer leur anxiété, lors d'actes de soins douloureux d'intensité légère à modérée et de courte durée.

Vidéo d'utilisation

Traçabilité dans DxCare

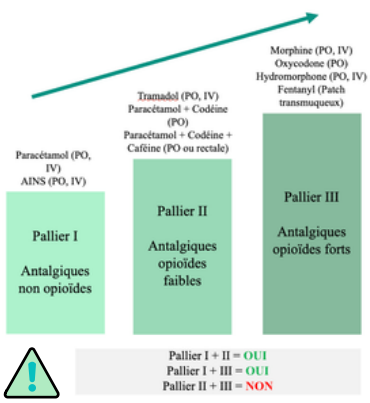


Charte de la douleur



*TM : Traitement médicamentaux
*TNM : Traitement non médicamentaux
**Tracer la douleur par le TILT : Type de douleur, Intensité, Localisation, Temporalité

TTT Médicamenteux



TTT Non Médicamenteux



Cousin de décharge



Echarpe d'immobilisation



Réalité virtuelle



Hypnose conversationnelle



Musicothérapie



Poche de froid

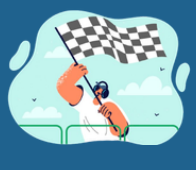
Ré-évaluation de la douleur

Elle est systématique à l'arrivée de tout patient entant dans un service d'urgences, doit être répétée en particulier pour tout malade auquel une thérapeutique antalgique est prescrite pendant le temps de passage aux urgences.

Toutes les 4h ou 45min à 2h après administration d'un antalgique

Prescription possible dans les protocoles soignants sur DxCare





OBJECTIF CERTIF



Circuit du médicament & pharmacovigilance

Juin 2026

Les critères impératifs :

Chapitre 2 - Les équipes de soins

2.2-02 : Les équipes **respectent** les **bonnes pratiques de prescription** des médicaments.
2.2-05 : Les équipes **respectent** les **bonnes pratiques d'administration** des médicaments.
2.2-06 : Les équipes **préviennent** les **risques d'erreur** médicamenteuse.
2.4-02 : La **pertinence** des **prescriptions d'antibiotiques** est **argumentée** et **réévaluée**.

Zoom sur les bonnes pratiques de prescription



Prescrire exige :
Compétence
Autorisation
Traçabilité

Comment vous assurez-vous que les professionnels disposent des titres et compétences nécessaires ?

Experts visiteurs



1. La gouvernance formalise la liste des professionnels habilités à prescrire
2. La liste est à jour des arrivées et départs, des autorisations d'exercice, des reconnaissances des qualifications
3. Profils utilisateurs adaptés aux différents types de prescripteurs
4. Mise en place et suivi des droits d'accès aux Logiciel d'aide à la prescription

La sécurisation commence AVANT l'acte de prescrire

Le si besoin

Traitement en **"si besoin"** oui, mais... en toute sécurité



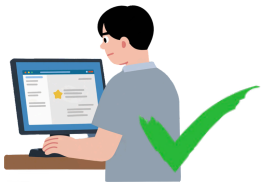
Une prescription conditionnelle s'accompagne d'une valeur seuil ET des conditions d'administration : dose par prise, intervalle entre prise, nb maxi prises /j, durée

Ex : paracétamol (si fièvre) → si T > 38.5°C : 1 g par prise, minimum 8 h entre chaque prise, 3 g/jour, pendant 2 jours.

Pas de prescription verbale

Disposer d'une prescription informatique ou écrite évite une administration dramatique (hors urgence vitale)





L'oral peut être vite oublié, l'écrit reste pour sécuriser

Zoom sur la pertinence des prescriptions d'antibiotiques

Avant de prescrire :

- *Ai-je une indication claire ?*
- *Ai-je consulté le référentiel local ou national ?*



Entre 24-72h :

- *Puis-je arrêter ?*
- *Puis-je adapter ou réduire ?*
- *Ai-je tracé ma réévaluation dans le dossier patient ?*

Travail en équipe : Microbiologiste – Pharmacien – Équipes de soin

Il vous aide

- ***Décider** : bon antibiotique, bonne indication*
- ***Réévaluer** : désescalade, adaptation, durée*
- ***Sécuriser** : limiter résistances et effets indésirables*

Quand le solliciter

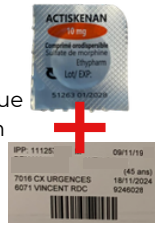
- *Doute sur indication*
- *Antibiotique large spectre*
- *Traitement > 72 heures*
- *Échec clinique*
- *Résultat microbiologique complexe*

Une prescription et/ou sa prolongation = justification + réévaluation

Les stupéfiants

Chaque blister doit avoir une étiquette patient ***OBLIGATOIREMENT***

- Les stupéfiants sont stockés dans un coffre ou un tiroir fermé à clé ou à code exclusivement réservé à cet effet.
- L'administration est effectuée au vue de la P.M. Elle est tracé dans le plan de soins et sur les relevés d'administration papier spécifique.



Les stupéfiants ne sont pas préparés dans le pilulier de 24h

Pour aller plus loin

HAS HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Newsletter n°5 - Circuit du médicament & pharmacovigilance

Diffusion en interne

Service des urgences

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Création G. SILVETTI

OBJECTIF CERTIF

Circuit du médicament & pharmacovigilance

Juin 2026

Zoom sur les bonnes pratiques d'administration

Règle des **5B**

Bon patient
Vérification de l'identité

Bon médicament
Concordance avec la prescription

Bonne dose
Respect de la posologie prescrite

Bon voie
Voie d'administration conforme

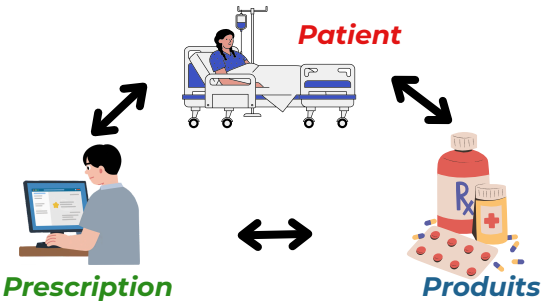
Bon moment
Respect du moment de prise

Chaque administration ou non-administration est tracée dans le dossier au plus près de la prise.

De la préparation à l'injection
LE MÊME ACTEUR
sans interruption !

Identification du patient

Avant d'administrer, je suis certain de toutes les identités !



L'identité du patient est revérifiée au moment de l'injection ou délivrance

Zoom sur la prévention des risques d'erreurs médicamenteuses

Médicaments à risque

IMPORTANT !



Etiquette rouge = Médicaments à risques

Affiche dans le poste de soins



Identification des tirroirs



Ressemblance = Vigilance



Nombreuses sont les erreurs médicamenteuses sont dues à une similitude de conditionnement



Pilulier

COMMENT faire un pilulier :
- **1 pilulier** à la fois, patient après patient
- à partir de la **prescription**
- pour **24 heures** maximum
- par **une seule personne**
- **moment dédié** pour limiter les interruptions de tâche



1. Numéro de la chambre
2. Etiquette patient dans le 1er compartiment

Traitements « Si besoin » :
Emplacements dédiés et étiquetés dans chariot de distribution

Traitements « Multidoses nominatifs » de grande taille :
***Emplacements dédiés** et **Traitements identifiés** avec l'**étiquette patient**. **Dates/heure** d'ouverture **notées** et stabilité vérifiée*
Attention : pour les stylos et seringues pré remplis : mettre l'étiquette du patient sur le corps et non sur le bouchon

Généralisons les mesures à prendre pour les éviter



Création G. SILVETTI

OBJECTIF CERTIF

Urgences vitales

Juin 2026

Les critères impératifs :

Chapitre 2 - Les équipes de soins

2.2-12 : Les équipes maîtrisent la prise en charge des urgences vitales

La prise en charge des urgences vitales repose sur trois piliers essentiels : la rapidité d'intervention, la coordination des équipes et la préparation continue.
Elle nécessite une identification rapide de la situation, une communication efficace entre les professionnels et un accès immédiat au matériel et aux traitements.
La formation régulière, notamment par des simulations, permet d'évaluer et d'améliorer en continu les pratiques.



Numéro de la réanimation 73 33

Le chariot d'urgence

Sur le chariot
Défibrillateur
Potence
Stéthoscope,
BAVU,
Poche contre-pression,
Médi-mémo SAUVE
Patch défibrillateur

Derrière le chariot
Planche à masser





Localisation des chariots d'urgences : SAUV, SAUV 5/Box 8 Lits d'Urgences (entrée/sortie de la réserve)

Sur le côté
OPTC
Sonde d'aspiration
Mandrin d'Eschmann

1. **Circulatoire**
   Drogues
   Thérapeutiques (injectable)
2. **Circulatoire**
   Prélèvement & injection
3. **Circulatoire**
   Perfusion
4. **Respiratoire**
   Intubation et insufflation
5. **Respiratoire**
   Oxygénothérapie
   Aérothérapie
   Matériel digestif
6. **Divers**
   Solutés

Le Médi-Mémo

N'oubliez pas votre Médi-Mémo SAUV !
Il regroupe toutes les thérapeutiques utilisées en SAUV ainsi que leurs modes de préparation, de façon claire et pratique.
Conçu pour être intuitif et facile d'utilisation, il vous aide au quotidien tout en limitant le risque d'erreur.



Pensez à scanner le QR code pour l'avoir toujours avec vous, directement dans vos notes ou sur votre téléphone !

Les 10 commandements



1. **Constater** l'Arrêt cardio-respiratoire.
2. Alerter le **7333** à Saint-Jo.
3. **Débuter** le **Massage Cardiaque** 100 à 120/min avec planche à masser.
4. **Libérer** les voies aériennes.
5. Ventilation BAVU branchée sur **Oxygène 15l/min**.
6. **30 compressions** pour 2 insufflations.
7. **Poser 1 voie veineuse** avec 1l NaCl 0,9% + robinet.
8. **Préparer** sans injecter une seringue de **10mg d'Adrénaline**.
9. Préparer l'**aspiration murale**.
10. **Vérifier identité** du patient et **noter les horaires**.

AFGSU
L'AFGSU niveau 2 est quant à elle **OBLIGATOIRE** pour tous les professionnels de santé
A renouveler tous les 4 ans
Fais le savoir à l'encadrement

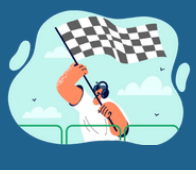
Les détresses vitales



Circulatoire **Respiratoire** **Neurologique**

NEW
Un registre de traçabilité de l'utilisation du chariot d'urgence (drogues, dispositifs médicaux, etc.) est demandé par l'HAS. Il sera mis en place prochainement.

Création G. SILVETTI



OBJECTIF CERTIF

Juin 2026

Hygiène - Prévention du risque infectieux

Les critères impératifs :

Chapitre 2 - Les équipes de soins

2.2-08 : Les équipes **respectent** les **précautions standards** d'hygiène.

Les critères standards :

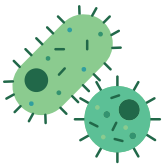
2.2-09 : Les équipes **respectent** les **précautions complémentaires** d'hygiène
2.2-10 : Les équipes **maîtrisent** le **risque infectieux** lié aux **dispositifs médicaux**.

Les précautions en prévention des infections associées aux soins comprennent l'ensemble des mesures visant à réduire la transmission des micro-organismes entre les patients, le personnel soignant et leur environnement. Elles se répartissent en deux catégories :



Les **précautions standard (PS)**, constituent la base de la prévention de la transmission de micro-organismes. Elles doivent être appliquées par tous les professionnels de santé pour tout soin, en tout lieu, et pour tout patient, quel que soit son statut infectieux.

Les **précautions complémentaires (PC)** viennent en complément des PS (avec une place à privilégier pour l'hygiène des mains par friction hydroalcoolique). Ces PC associées aux PS chez un patient porteur de micro-organisme émergent à haut potentiel de transmission croisée (SARM, entérobactérie productrice d'une beta lactamase à spectre étendu E BLSE).



Les précautions standard (PS)



La tenue professionnelle

La tenue professionnelle assure une **protection du personnel et des patients**.
Elle a pour objectif de **prévenir la transmission** de micro-organismes.
Il est donc **interdit** de **sortir de l'hôpital**, de **déjeuner au self** ou de **s'asseoir sur les pelouses en tenue**

Quelques rappels

- **Tenue propre à manches courtes.**
- **Cheveux propres, courts ou attachés.**
- **Ongles courts, propres, sans vernis et sans faux ongles.**
- **Les mains et les avant-bras sans bijoux, ni alliance**



Création G. SILVETTI

OBJECTIF CERTIF

Juin 2026

Hygiène - Prévention du risque infectieux

Les critères impératifs :

Chapitre 2 - Les équipes de soins

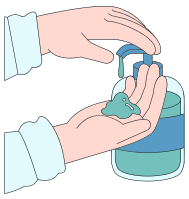
2.2-08 : Les équipes **respectent** les **précautions standards** d'hygiène.

Les critères standards :

2.2-09 : Les équipes **respectent** les **précautions complémentaires** d'hygiène

2.2-10 : Les équipes **maîtrisent** le **risque infectieux** lié aux **dispositifs médicaux**.

Lavage des mains

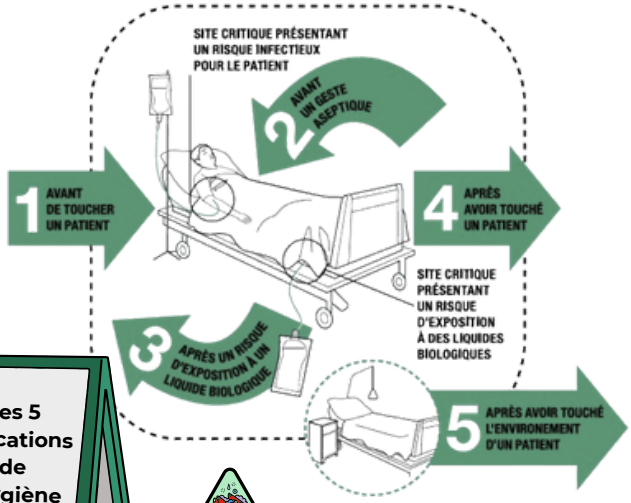


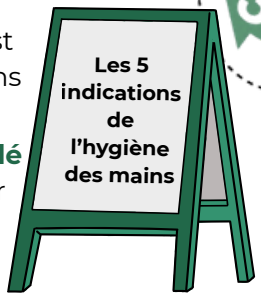
Les germes sont principalement transmis par les mains au cours les soins

L'hygiène des mains est la mesure essentielle à appliquer pour prévenir la transmission des germes et le développement des infections associées aux soins.

La **friction des mains** avec un produit hydroalcoolique est la **méthode de choix** pour pratiquer l'antisepsie des mains de routine

Le **lavage des mains au savon et à l'eau** est **recommandé** lorsque les mains sont **visiblement sales** ou **souillées** par du sang ou d'autres liquides biologiques, **ou après être allé aux toilettes.**





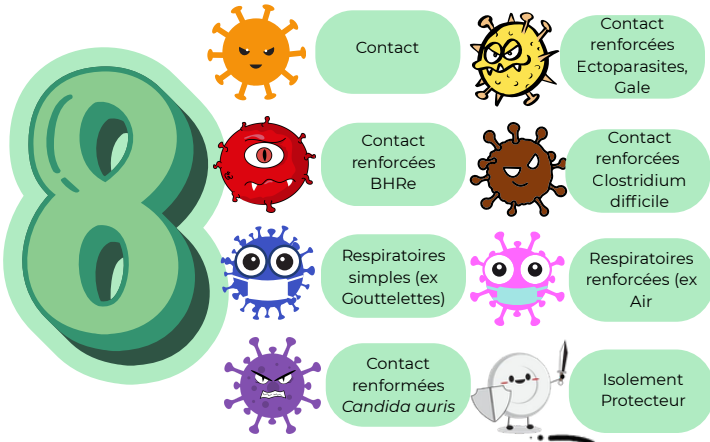


Aux urgences
5 frictions / passage

ICSHA

L'ICSHA est un des indicateurs de la lutte contre les infections nosocomiales.

Précautions complémentaires



Gestion des excretas

Les excreta désignent les substances produites par le métabolisme et éliminés par l'organisme : principalement l'urine, les matières fécales et les vomissures.

Elimination



Acheminement protégé des bassins, urinaux et chaises percées (couvercle ou sac) vers un **lave-bassin**.

Soignant



Entretien des surfaces et matériels



Linge



Poubelle



Retrouve toutes les fiches sur BlueKanGo ou

Pour aller plus loin

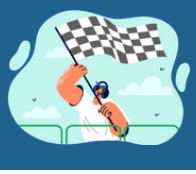
HAS HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Diffusion en interne

Service des urgences

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Création G. SILVETTI



OBJECTIF CERTIF



Mai 2026

Bientraitance, dignité, informations du patient et confidentialité.

Les critères impératifs :

Chapitre 1 - Le patient

1.1-01 : Le patient **bénéficie** du **respect** de son **intimité** et de sa **dignité** au sein d'un environnement sécurisé.

1.1-06 : Le patient **bénéficie** d'une prise en charge **bientraitante**.

Dans le cadre de la prise en charge des patients, la bientraitance, l'information du patient et le respect de la confidentialité constituent des éléments fondamentaux de la qualité et de la sécurité des soins.
Ces principes impliquent une posture professionnelle adaptée, fondée sur le respect de la dignité, l'implication du patient dans son parcours de soins et la protection de ses données personnelles. Ils nécessitent une vigilance constante et une adaptation des pratiques au quotidien.



Bientraitance

La bientraitance est une démarche collective pour identifier le meilleur accompagnement possible du patient, dans le respect de ses choix et dans l'adaptation la plus juste à ses besoins.

La maltraitance correspond à un geste, une parole, une action ou un défaut d'action qui a pour effet de porter atteinte aux droits ou aux besoins fondamentaux.

Exemples de maltraitance ordinaire :

- Les soignants qui parlent entre eux devant le patient en l'ignorant
- La sonnette qui est placée du côté paralysé du patient
- Des propos tels que « Faites dans la couche, je passerai plus tard »

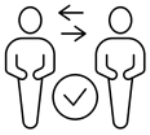


Dignité

La dignité, c'est le fait que chaque personne a de la valeur et mérite le respect, simplement parce qu'elle est un être humain.

Respect que l'on doit à une personne :

- Je frappe à la porte avant d'entrer dans la chambre du patient.
- Je ferme la porte de la chambre lorsque je réalise un soin. Je mets le paravent dans les chambres doubles.
- Je réponds aux besoins fondamentaux des patients (accompagnement aux toilettes, alimentation et hydratation, ...).
- Je couvre le patient (drap ou couverture) dans les zones de circulation et d'attente.
- Je m'adresse aux patients de manière courtoise et respectueuse.



Informations

Information et implication du patient

- Le patient doit pouvoir participer aux projets de soins qui le concerne : il exprime ses besoins et ses préférences qui seront pris en compte autant que possible.
- Le patient, sans avoir à le demander, est informé de son diagnostic, son état de santé, ses traitements, ses soins et la durée prévisionnelle de sa prise en charge, ...
- Importance de la traçabilité de l'information donnée au patient et à ses proches.



Confidentialité

Toute personne prise en charge par un professionnel ou un établissement des secteurs de la santé et des secteurs social et médico-social a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Tous les professionnels sont soumis au **SECRET PROFESSIONNEL**.
Aucune information médicale ne doit être accessible depuis les couloirs ou les chambres → attention aux écrans d'ordinateur, dans le couloir, qui affichent les dossiers des patients.
Aucun renseignement médical ne doit être transmis par téléphone.
Il est **interdit de communiquer sur les réseaux sociaux** des informations sur les patients (photos, anecdotes, ...).



OBJECTIF CERTIF

Juin 2026

Sécurité transfusionnelle et Etraceline

La sécurité transfusionnelle a pour objectif d'identifier les dangers ayant causé, causant ou susceptible de causer des incidents ou des effets indésirables qui ont menacé, menacent ou peuvent menacer la santé des donneurs ou des receveurs afin d'en éliminer ou d'en réduire les risques associés.

La sécurité transfusionnelle

- Débute dès le prélèvement du groupe sanguin.
- Redémarre au contrôle à récepetion des PSL dans le service
- Se poursuit au contrôle ultime au lit du malade (CULM)
- Se termine à la fin de la transfusion avec la traçabilité.

Médicalement

La décision d'un acte transfusionnel est prise par le médecin selon une analyse bénéfices/risques évaluée selon des **critères cliniques et biologiques ET** correspondant au **protocole du service**.
Le médecin informe le patient avant la transfusion expliquant les bénéfices/ risques associés.

Prescription des CGR sur Etraceline et sur DxCare

Si refus, traçabilité dans le dossier transfusionnel.

Prélèvement du groupe sanguin

1. Je demande au patient de décliner son décliner : Nom de naissance ; Nom d'usage ; Prénom ; Date de naissance ; Genre.
2. Je vérifie en même temps le(s) étiquette(s) à coller sur le tube.
3. Je prélève le tube puis je colle l'étiquette dessus.
4. Je montre le tube au patient : il relit l'étiquette pour vérifier.
5. Je peux envoyer le tube au laboratoire

Pour la 2nde détermination :

- répéter la même procédure dans un 2nd temps
- Cette 2nde détermination permet de récupérer une éventuelle erreur de patient lors du 1er prélèvement

A chaque étape : Identito-vigilance

En transfusion, erreur d'identitovigilance = erreur transfusionnelle (porte ouverte à l'accident transfusionnel ABO)



2 temps :

- 15 minutes d'intervalle
- 2 IDE *(idéalement)*

Ne pas prélever les 2 déterminations lors du meme prélèvement

Contrôle Ultime au Lit du Malade

1. Contrôle de la concordance
   - Même identité
   - Même groupage
   - Même type et quantité de PSL
   - Feuille de délivrance pour chaque PSL
2. Contrôle de compatibilité pour les CGR

A savoir

Si le patient est déjà venu, pensez à vérifier dans les résultats s'il possède déjà une carte de groupe.
Ou appel le dépôt de sang au

34.56

Traçabilité

Sur Etraceline

Traçabilité sur le logiciel, pas d'envoie de traçabilité à la banque du sang.

Sur papier

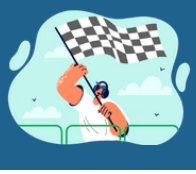
Fin de la transfusion : remplir le document, l'adresser à la banque du sang (Fax : 3973)

Urgences vitales

Transfusion à la SAUV uniquement si le patient est instable hémodynamiquement.

1 IDE dédiée
OBLIGATOIREMENT

Création G. SILVETTI



OBJECTIF CERTIF

Juillet 2026

Gestion des risques et démarche qualité

Les critères impératifs :

Chapitre 2 et 3 - Les équipes de soins et l'établissement

1.4-02 : La satisfaction et l'expérience du patient sont prises en compte.
1.4-03 : La gouvernance soutient l'utilisation des questionnaires visant les résultats de soins évalués par les patients.
3.1-04 : L'établissement impulse la culture de la déclaration des évènements indésirables, dont les presqu'accidents.

Les établissements de santé s'engagent dans des démarches visant à améliorer en continu la qualité des soins et la sécurité des patients.
L'amélioration de la qualité et la gestion des risques constituent deux approches complémentaires, reposant sur un management participatif et permanent, une culture de la sécurité des soins positive et constructive, ainsi qu'une mobilisation de l'ensemble des professionnels dans une logique d'amélioration au service des usagers.

CREX

Comité de **R**etour d'**EX**périence : Analyse collective des causes profondes de tous les évènements indésirables d'un secteur / service à périodicité régulière (imagerie / pharmacie par exemple).

RMM

Revue de **M**orbidité-**M**ortalité : Analyse collective et ponctuelle des causes profondes d'un évènement indésirable grave

Fiche d'Évenement Indésirable (FEI)

C'est un document utilisé pour signaler un problème, une erreur ou un dysfonctionnement survenu lors de la prise en charge d'un patient.

Évenement indésirable (EI)
Évenement inattendu dans la prise en charge médicale ou l'organisation et ayant eu un impact pour le patient, les professionnels ou l'institution.

Évenement indésirable grave (EIG)
Évenement inattendu ayant provoqué le décès, une mise en jeu du pronostic vital, une hospitalisation ou prolongation de l'hospitalisation, une incapacité fonctionnelle permanente...

Évenement porteur de risque (EPR)
Évenement inattendu qui aurait pu avoir es conséquences pour un patient, mais qui n'en a pas eu.

Que déclarer :
Tous les évènements indésirables car le traitement exclussif des EIG et EPR ne permet pas d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant

Qui déclare :
Tous les professionnels

Protocole

C'est un ensemble de règles et de recommandations qui décrit comment prendre en charge une situation médicale donnée.

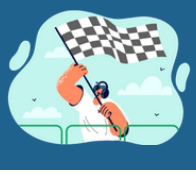
Il répond à la question : **"Que doit-on faire dans cette situation ?"**

BlueKanGo

Procédure

C'est est une description précise, étape par étape, de la manière de réaliser un acte.

Elle répond à la question : **"Comment faire concrètement ?"**



OBJECTIF CERTIF



Juillet 2026

Gestion des risques et démarche qualité

Les critères impératifs :

Chapitre 2 et 3 - Les équipes de soins et l'établissement

1.4-02 : La satisfaction et l'expérience du patient sont prises en compte.
1.4-03 : La gouvernance soutient l'utilisation des questionnaires visant les résultats de soins évalués par les patients.
3.1-04 : L'établissement impulse la culture de la déclaration des évènements indésirables, dont les presqu'accidents.

La démarche qualité gestion des risques de l'Hôpital Paris Saint-Joseph



Elle se traduit par les résultats suivants :

- **Le laboratoire de biologie médicale est accrédité par le COFRAC** (comité français d'accréditation) sous le n° 8-.3648.
- L'Hôpital est le 1er ESPIC à obtenir la **certification ISO 9001 pour ses activités biomédicales** en octobre 2014.
- L'Hôpital a obtenu en 2018 le **label E-RSE** dans le cadre de son engagement dans le développement durable
- L'Hôpital est engagé dans l'obtention du label **Don en confiance**.
- La maternité est engagée dans l'obtention du **label IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés)**.
- L'Hôpital est engagé au travers de sa commission Handicap dans l'obtention du **label S3A (Accueil, Accompagnement et Accessibilité) de l'UNAPEI**.

IQSS

Les IQSS sont les Indicateurs nationaux de Qualité et Sécurité des Soins suivis et recueillis chaque année par la HAS

Indicateurs avec financement	Indicateurs suivis mensuellement	Objectifs
Qualité de la lettre de liaison	Tx d'envoi à J0 - Cumulé	80%
	Qualité du contenu - Cumulé	80%
E-Satis	Indice de satisfaction global - Cumulé	75
	Indice de confiance des patients (NPS*) - Cumulé	65
Prise en charge de la douleur	Tx de prescriptions d'antalgiques de palier 3 à la demande	50%
Taux d'identités qualifiées	Hospitalisation	80%
	Consultation/Explos	80%
ICSHA 3	Tx de consommation des SHA - Cumulé	100%
Certification	Nombre de RMM - Cumulé	20/an
	Nombre de patients traceurs- Cumulé	20/an
Santé sécurité au travail	Nombre d'AES - Cumulé	< 60/an

Qualité de la lettre de liaison à la sortie
E-satis : La satisfaction et l'expérience du patient
Evaluation et prise en charge de la douleur
Taux d'identités qualifiées = **INS**
ICSHA : Indicateur de consommation des solutions hydro alcooliques
Certification
Santé et sécurité au travail

Ils sont affiché dans le Hall de l'hôpital et actualisé tous les mois.



Les vigilances sanitaires

- **Biovigilance**
- **Hemovigilance**
- **Identitovigilance**
- **Infectiovigilance**
- **Informaticovigilance**
- **Matériovigilance**
- **Pharmacovigilance**
- **Réactovigilance**

Différentes vigilances :

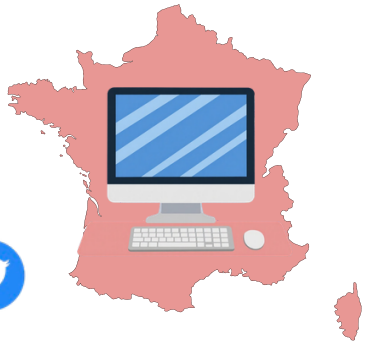
- **Ascendante** : signalement des établissements de santé vers les autorités sanitaires
- **Descendante** : Alerte des fournisseurs et/ou des autorités sanitaires vers les responsables vigilances des établissement de santé.

Pour déclarer un évènement en lien avec une vigilance ↪ **FEI**

OBJECTIF CERTIF

Août 2026

Prévention du risque numérique (réseaux sociaux)



Etat des lieux :

Environ **63,4** millions de Français utilisent Internet, soit plus de **95 %** de la population.
Les Français passent en moyenne près de **27 heures** par semaine en ligne.
Environ **51,5 millions** de Français utilisent les réseaux sociaux, soit **77 %** de la population.
Chaque utilisateur possède en moyenne **6** comptes .

Quels risques ?

Chacune de nos actions sur la toile va en effet laisser des traces numériques qui peuvent avoir des conséquences, aujourd'hui ou demain, positives ou négatives, dans notre « vie réelle ».

Médias sociaux & réseaux sociaux

Les **médias sociaux** permettent la création et l'échange de contenus générés par les utilisateurs. Ils favorisent la mise en relation d'individus dont les centres d'intérêt sont communs, en les amenant à coopérer en ligne, voire hors ligne. Tout utilisateur peut faire partager son opinion ou son expérience, par exemple concernant les produits ou services d'une entreprise.
Les **réseaux sociaux** sont des sites capables de fédérer des individus autour d'un intérêt commun (photos, actualités...), les réseaux sociaux mettent à disposition des utilisateurs des outils (messageries, partage de contenus...) qui facilitent la communication entre les membres du réseau.

> Il est interdit d'utiliser le logo du GHPSJ à des fins personnelles car il est déposé et protégé.

3 MOTS
Viralité
Réputation
Anonymat

Viralité :
Sur les réseaux sociaux, l'information se diffuse très rapidement grâce à la *viralité* : un message est partagé de contact en contact, amplifié par les interactions (like, partage, retweet). Résultat : une diffusion instantanée, massive et potentiellement illimitée.

Réputation numérique :
Votre identité est ce que vous déclarez sur vous-même. Vous avez une « identité sociale » et une « identité professionnelle ». Lorsque vous publiez votre cv sur LinkedIn, votre identité devient numérique.
Votre réputation est ce que les autres pensent de vous. Lorsque votre entourage professionnel donne son opinion sur vos compétences à travers des recommandations sur les réseaux sociaux, votre *réputation devient numérique*.

Anonymat :
L'anonymat sur internet n'existe pas.
Utiliser un pseudonyme ne constitue pas une garantie pour la sécurité des informations.
Si cela limite les effets de la prise de parole par rapport à une communication en votre nom personnel, son utilisation ne vous exonère pas de respecter le cadre légal dans la rédaction de vos contenus sur les médias sociaux.







Réglement intérieur du personnel de l'hôpital

Code de la Santé Publique :
Le patient a le droit « au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant ». Art. L. 1110-4

Charte de la personne hospitalisée :
« Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales la concernant ». Chapitre 9

Code civil :
Chaque individu a un droit exclusif sur son image et l'utilisation qui en est faite. La jurisprudence sanctionne l'atteinte au droit à l'image sur le fondement de l'article 9.

Code pénal :
La violation du secret professionnel peut être sanctionnée d'une faute grave, d'une amende et/ou d'un emprisonnement. Toute publication sur les réseaux sociaux d'information concernant un patient permettant de l'identifier constitue une violation du secret professionnel. Article 226-13

Les personnels du GHPSJ s'engagent à protéger et à ne pas divulguer d'informations concernant le patient. Ils respectent le secret professionnel. (Article 16)

Les personnels sont liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance dans leur exercice professionnel. (Article 17)

Dans le cadre de sa liberté d'expression à l'exterieur du GHPSJ, notamment sur les réseaux sociaux, les personnels doivent respecter l'image et la notoriété du GHPSJ, ainsi que la dignité de chaque salarié et de chaque patient. (Article 19)

Pendant la prise en charge d'un patient ou d'un personnel, il est interdit d'utiliser son téléphone portable personnel. Dans tous les cas, son utilisation ne doit pas entraver le bon déroulement de l'activité de travail du salarié. (Article 22)

Il est interdit pour tout salarié de l'établissement d'utiliser les téléphones portables pour photographier, filmer des membres du personnel, des patients ou tout tiers et /ou d'enregistrer des conversations d'ordre professionnel ou personnel dans le cadre de l'exécution de leurs missions au sein de l'établissement. (Article 22)



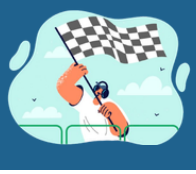
Les bonnes pratiques

Je **sécurise l'accès** à mes profils sur les réseaux sociaux
Je **sépare** ma vie personnelle de ma vie professionnelle
Je **distingue** "parler de l'hôpital" et "parler au nom de l'hôpital"
Je suis **vigilant** au contenu que je poste.
Je **vérifie** les paramètres des réseaux sociaux que j'utilise

Ce n'est pas parce que les noms des patients sont changés qu'une famille ne peut pas se reconnaître.

> Pour pouvoir utiliser la photo d'une personne, il est nécessaire de lui faire signer une autorisation de prise de vue et de diffusion de l'image.

Création G. SILVETTI



OBJECTIF CERTIF



Août 2026

Prévention du risque numérique (réseaux sociaux)

Cyberattaque



En France, les cyberattaques visant les hôpitaux se multiplient.
Entre 2022 et 2023, plus de **30** hôpitaux français ont été **victimes** de **cyberattaques** majeures, essentiellement des rançongiciels (ransomware).
En **2024**, ce chiffre n'a cessé d'augmenter.
Le secteur de la santé représente désormais l'une des cibles les plus fréquentes des hackers, avec une augmentation continue des tentatives d'intrusion

Les attaques les plus courantes



- **Rançongiciels (ransomware)** :
  - *ces programmes malveillants chiffrent les données hospitalières et exigent une rançon pour les débloquer.*
- **Fuites de données sensibles** :
  - *exfiltration de dossiers patients, de comptes rendus médicaux ou de données administratives.*
- **Phishing & vulnérabilités techniques** :
  - *envoi de mails frauduleux, exploitation de failles logicielles ou de dispositifs connectés peu sécurisés.*

Enjeux et conséquences



- **Rupture de la continuité des soins :**
  - *annulation d'interventions chirurgicales, transfert de patients, perte de données vitales.*
- **Atteinte à la confidentialité :**
  - *dossiers médicaux exposés, patients potentiellement identifiables, perte de confiance.*
- **Coûts financiers élevés :**
  - *coûts de remédiation, rançons (parfois payées à contrecœur), investissements d'urgence en cybersécurité.*
- **Fatigue et stress du personnel :**
  - *surcharge administrative, perte de repères numériques, pression médiatique.*

Consignes de sécurité en cas de cyberattaque

3 Consignes

1. **Je débranche le PC du réseau, mais pas du secteur**
2. **J'appelle le 11 ou le 3300 ou le cadre de garde (nuit et weekend)**
3. **J'avertis mes collègues et mon cadre**

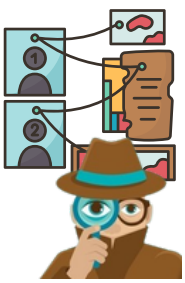
Vous recevez un mail douteux ?
NE cliquez PAS sur le lien !
Transférer à
securite.informatique@ghpsj.fr

Que faire en cas de perte ou de problème avec mon identifiant/mot de passe ?
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre cadre/référent pour effectuer une demande par mail adressée à onze@ghpsj.fr

Mon mot de passe :
12 caractères min) : majuscule, minuscule, chiffre, caractère spéciale sauf &, § et µ/ pas de nom, ni de prénom, ni de date de naissance

Ne pas modifier son mot de passe sur son téléphone.
Votre compte outlook (messagerie) et directement lié à votre compte Windows

Identifier une cyberattaque potentielle

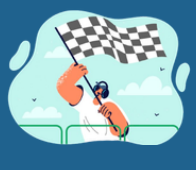


Si vous avez un de ces signaux :

- Ma souris bouge toute seule alors que je n'ai pas connaissance d'une intervention informatique en cours
- Impossible pour moi et mes collègues de nous connecter aux PC du service
- Mes applications et fichiers s'ouvrent et se ferment sans mon autorisation
- Je n'ai plus les droits sur mes documents pour les ouvrir ou les modifier
- Je reçois un message sur mon PC ou par email avec une demande de rançon en € ou Bitcoin
- Des messages et des images indésirables s'affichent sur mon écran
- Mon PC est très lent même après redémarrage ou des icones blanches apparaissent à la place de mes fichiers avec un nom différent que je n'ai jamais vu auparavant.



Création G. SILVETTI



OBJECTIF CERTIF



Gestion de crise et procédures dégradées

Août 2026

Les critères impératifs :

Chapitre 3 - L'établissement

3.1-05 : La **gestion** des **situations sanitaires exceptionnelles** est **maîtrisée**



L'Etat dispose de nombreux plans, développés au niveau local ou national en prévision d'accidents de grande ampleur et de catastrophes, destinés à favoriser la qualité de sa réaction et de ses actions.
Les plans consistent notamment à :

- Permettre une optimisation de la mobilisation des ressources utiles pour faire face aux situations
- Faciliter et guider le processus de prise de décision des autorités publiques
- Proposer des mesures et plans d'action

Définition

ORSEC :
Organisation de la **R**éponse de **SE**curité **C**ivile.

ORSAN :
Organisation de la **R**éponse du système de santé en situations **SAN**itaires exceptionnelles.

NOVI :
NOmbreuses **VI**ctimes (plan d'urgence pour secourir un nombre important de victimes dans un même lieu)

AMAVI :
Accueil **MA**ssif de **VI**ctimes non contaminées (volet du plan ORSAN)

Plan Blanc :
Dispositif de crise obligatoire dans chaque établissement de santé

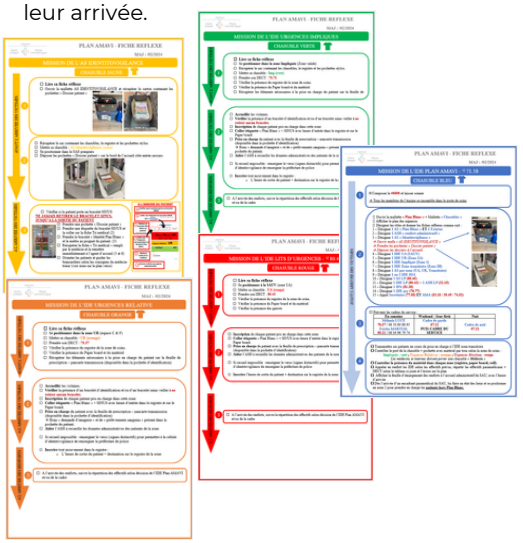
ORSAN

Le dispositif ORSAN organise et adapte les soins au niveau régional afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes malades puissent bénéficier des soins appropriés.
Il comprend 5 volets qui servent à organiser les soins quand l'une des 5 situations susceptibles d'impacter le système de santé survient

- ORSAN AMAVI
- ORSAN MEDICO-PSY
- ORSAN EPI-CLIM
- ORSAN NRC
- ORSAN REB

Fiches réflexes

création de fiches réflexes pour chaque poste. Ces fiches ont pour objectif de faciliter le travail de chacun en énumérant clairement la liste des tâches à accomplir, tout en précisant le déroulement et le timing des actions, tant avant l'arrivée des victimes qu'au moment de leur arrivée.



Déclenchement



Plusieurs possibilités :

- **ARS**
  - En lançant une alerte aux établissements de santé.
- **SAMU**
  - Appel les services d'urgences.
- **Afflux massif de victimes**
  - présentant des signes cliniques évocateurs ou des discours cohérents : lieu, évènement, ...)

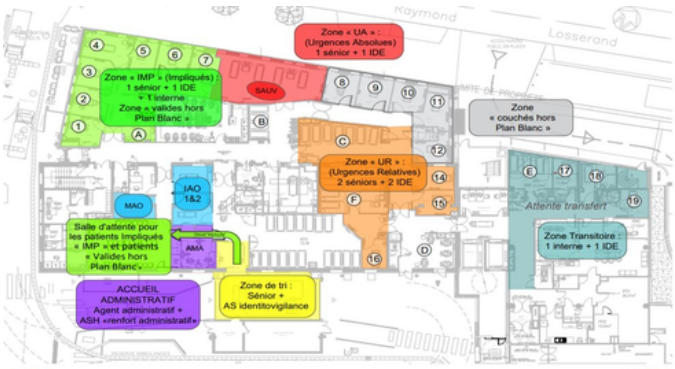
Déclenchement d'un Plan Blanc

Organisation

Organisation du service par zone

- **Zone de tri**
- **Zone impliqués**
- **Zone urgence relative**
- **Zone urgence absolue**
- **Zone transitoire**

+ Zone hors Plan AMAVI



OBJECTIF CERTIF

Gestion de crise et procédures dégradées

Août 2026

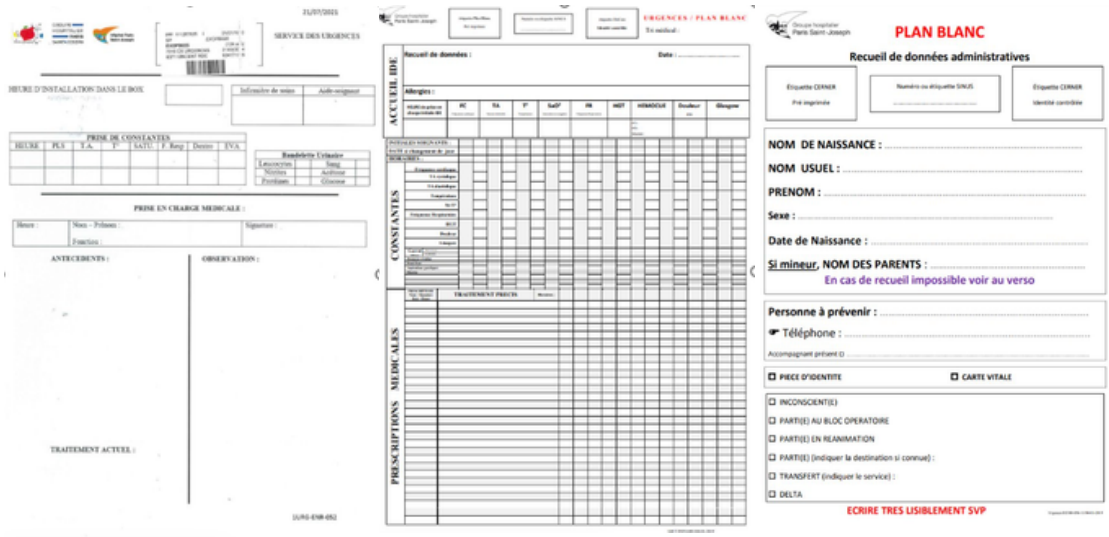
Les critères impératifs :

Chapitre 3 - L'établissement

3.1-05 : La **gestion** des **situations sanitaires exceptionnelles** est **maîtrisée**

Dossier papier

Lors d'un plan AMAVI, il n'y a pas d'utilisation de dossier informatique. Seul le dossier papier est utilisé. Ce dossier doit être placé dans une pochette attachée à la victime et ne doit en aucun cas quitter le patient.



C'est le même dossier que lorsqu'il y a des coupures DxCare programmé.

Bracelet

les victimes arriveront aux urgences avec ou sans de bracelet SINUS.

Lors de leur accueil, l'AS identito-vigilance mettra un bracelet identité plan AMAVI au poignet du patient.



Bracelet SINUS



Bracelet identité AMAVI



Bracelet identité vérifiée

Avant vérification de l'identité

Après vérification de l'identité



Les bracelets ne doivent jamais être coupés

Les victimes impliqués, peuvent n'avoir qu'un seul bracelet, celui de l'identité vérifiée.

Vidéo

Afin de vous aider à comprendre l'organisation du service lors d'un plan AMAVI, regarder la vidéo réalisée par nos acteurs locaux.

Partie Médicale et Paramédicale

Partie administratif

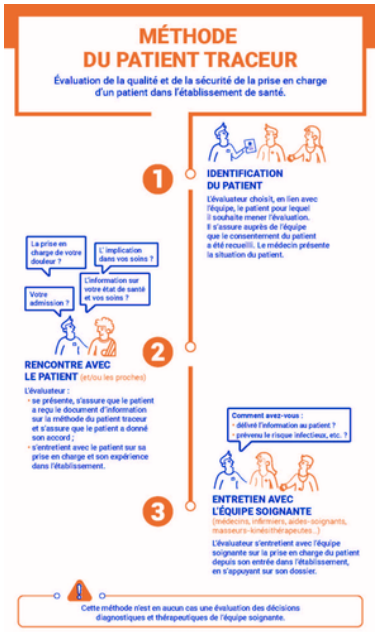
Les cinq méthodes d'évaluations

Septembre 2026

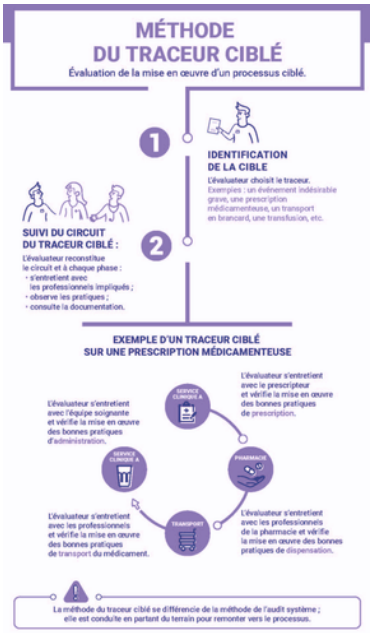
Chaque critère est évalué par une ou plusieurs des cinq méthodes suivantes :

Le patient traceur | Le parcours traceur | Le traceur ciblé | L'audit système | L'observation

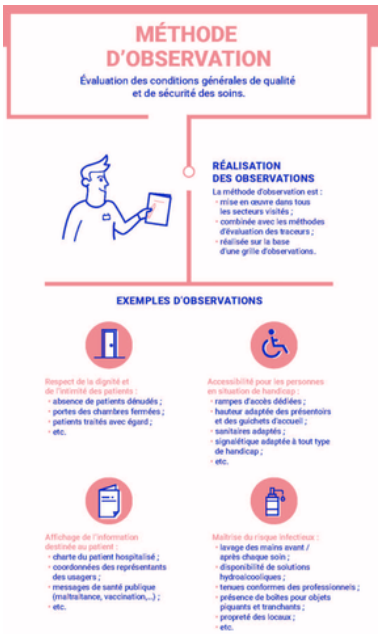
Ces méthodes sont utilisées par les experts-visiteurs de la HAS durant la visite de certification et, s'ils le souhaitent, par les évaluateurs de l'établissement dans le cadre de son évaluation interne. Ce terme d'évaluateur, utilisé dans les paragraphes suivants, s'entend pour les experts-visiteurs et pour l'évaluateur interne de l'établissement.

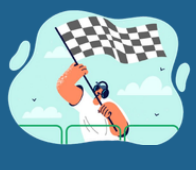












OBJECTIF CERTIF

Les cinq méthodes d'évaluations

Septembre 2026

Le **patient traceur** a pour objectif d'évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge. Lors de la visite HAS cette méthode n'est réalisée que par des experts-visiteurs médecins.

En pratique : Un patient traceur aura lieu dans chacun des services de l'hôpital. L'expert visiteur choisit un patient interrogeable et proche de la sortie. Il recueille le consentement de celui-ci puis le médecin référent présente le cas du patient à l'expert. Cette méthode se réalise ensuite à l'aide d'une grille découpée en 3 parties :

1. L'interrogatoire du patient pour recueillir son expérience (46 questions)
2. L'interrogatoire de l'équipe pour vérifier la cohérence des réponses avec celles du patient (30 questions)
3. La consultation documentaire c'est à dire la vérification de la traçabilité dans le dossier du patient (8 questions)

La méthode de **l'audit système** consiste à évaluer un processus. Il comprend une rencontre avec la gouvernance puis une rencontre avec les professionnels.

Au cours de la visite de certification, six processus seront évalués lors de 3 rencontres avec la gouvernance :

- La coordination territoriale et L'engagement patient
- Le leadership & qualité de vie au travail et le travail en équipe
- La maitrise des risques et la dynamique d'amélioration

Ces rencontres avec la gouvernance seront complétées avec une rencontre avec les représentants des usagers et une dizaine de rencontres avec des professionnels.

En pratique :

1. Rencontre des membres de la gouvernance concernés par le sujet (direction, présidence de CME, coordonnateurs médicaux et paramédicaux, représentants des usagers, équipe qualité gestion des risques, etc.)
2. Rencontre avec les représentants des usagers
3. Rencontre d'une dizaine d'équipes de professionnels (réparties sur la semaine) pour évaluer la mise en œuvre des six processus sur le terrain à l'aide d'une grille de 43 questions posées aux professionnels

La semaine de visite de certification, nous saurons la veille dans quels services les experts visiteurs iront interroger les professionnels.

Le **parcours traceur** est une méthode qui a pour objectif d'analyser la **coordination entre les services**, le travail en équipe ainsi que **la continuité de la prise en charge** (ex : parcours AVC, césarienne programmée, cancer du sein, ...). Cette méthode se réalise à l'aide d'une grille de 74 questions.

En pratique : Les parcours (environ quinze) qui seront effectués par les experts seront communiqués 2 ou 3 semaines avant la visite. Le jour J l'évaluateur rencontre les équipes impliquées dans la prise en charge en s'appuyant sur un dossier type ou "fil rouge" proposé par les équipes concernées. Quatre autres dossiers également proposés par les équipes pourront être investigués. Ensuite, l'évaluateur retrace le parcours physique du patient et rencontre les professionnels présents afin de compléter son évaluation. Des parcours pourront aussi être définis au cours de la visite.

Le **traceur ciblé** est une méthode d'évaluation qui consiste à évaluer, sur le terrain, la mise en œuvre d'un processus. Il y a 6 traceurs ciblés différents :

- Circuit du médicament et des produits de santé *(14 questions aux professionnels + 4 à la gouvernance + 1 consultation de dossier (CD))*
- Prévention des infections associées aux soins *(24 questions aux professionnels + 2 à la gouvernance + 2 CD)*
- Gestion des événements indésirables *(3 questions aux professionnels + 2 à la gouvernance + 1 CD)*
- Accueil non programmé *(3 questions aux professionnels + 2 à la gouvernance + 1 CD)*
- Transport en intra-hospitalier des patients *(3 questions aux professionnels + 2 à la gouvernance + 1 CD)*
- Gestion des produits sanguins labiles *(3 questions aux professionnels + 2 à la gouvernance + 1 CD)*

En pratique : L'évaluateur choisit un service (communiqué la veille) et rencontre les équipes, consulte les documents nécessaires et réalise des observations à l'aide d'une grille de questions (1 grille par traceur).

Les observations sont réalisées lors de chacune des autres méthodes, sur la base d'une liste de points observables sur le terrain, comme :

- Le respect de la dignité et de l'intimité du patient (pas de patients dénudés, portes fermées...)
- L'accessibilité des locaux (rampe d'accès, ascenseur, signalétique...)
- La maîtrise du risque infectieux (tenue des professionnels, boîtes pour objets piquants et tranchants, hygiène des mains, etc.)
- L'identification des médicaments à risque
- L'accès au chariot d'urgence

En pratique : Durant toute la semaine d'évaluation, tous les professionnels seront observés dans leurs pratiques de façon continue.